Primeiros Socorros no Karatê

Guia para Professores e Instrutores — FIKARJ · 27 de outubro de 2026 · Roosevelt Couto Barbosa de Souza

Aviso importante: este material é educativo. Não substitui um curso certificado de primeiros socorros/RCP (Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha ou SAMU local) nem atendimento médico. A FIKARJ recomenda fortemente que todo professor e árbitro faça um curso certificado de RCP/DEA com reciclagem periódica.

Este guia foi feito para professores e instrutores de karatê da FIKARJ que precisam saber agir nos primeiros minutos de um acidente no dojo ou em competição — antes da chegada de socorro especializado.

O papel do professor nos primeiros minutos é:

1. Garantir a segurança da cena.
2. Avaliar rapidamente a vítima.
3. Acionar o SAMU (192).
4. Aplicar manobras básicas que não exigem diagnóstico médico (RCP, DEA, desengasgo, controle de sangramento, imobilização por posicionamento).
5. Nunca tentar reduzir luxações, recolocar ossos, dar medicação que não seja do próprio atleta, ou mover vítima com suspeita de lesão na coluna.

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 1 de 7

Introdução

Este guia foi feito para professores e instrutores de karatê da FIKARJ que precisam saber agir nos primeiros minutos de um acidente no dojo ou em competição — antes da chegada de socorro especializado.

> **Aviso importante:** este material é educativo. Ele não substitui um curso certificado de primeiros socorros/RCP (Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha ou SAMU local) nem substitui atendimento médico. A FIKARJ recomenda fortemente que todo professor e árbitro faça um curso certificado de RCP/DEA com reciclagem periódica — é o fator que mais eleva a chance de sobrevivência em emergências esportivas.

O papel do professor nos primeiros minutos é:

1. Garantir a segurança da cena.
2. Avaliar rapidamente a vítima.
3. Acionar o SAMU (192).
4. Aplicar manobras básicas que não exigem diagnóstico médico (RCP, DEA, desengasgo, controle de sangramento, imobilização por posicionamento).
5. Nunca tentar reduzir luxações, recolocar ossos, dar medicação que não seja do próprio atleta, ou mover vítima com suspeita de lesão na coluna.

1. Avaliação inicial da vítima

Antes de qualquer ação, siga esta sequência (adaptada do protocolo ABC):

1. **Segurança da cena** — verifique riscos antes de se aproximar (tatame livre, outros atletas afastados).
2. **Responsividade** — chame em voz alta e toque os ombros: "Você está bem? Consegue me ouvir?"
3. **Se não responde** — grite por ajuda, mande alguém ligar para o SAMU (192) e buscar o DEA, e comece a avaliação.
4. **Vias aéreas e respiração** — observe/ouça/sinta a respiração por até 10 segundos. Respiração "agonizante" (gasping) ou ausente = trate como parada cardiorrespiratória.
5. **Circulação/sangramento** — verifique hemorragias visíveis e controle com pressão direta.

> **Regra de ouro:** se a vítima não responde e não respira normalmente (ou só "gasping") — presuma parada cardíaca e inicie a RCP imediatamente. Colapso súbito sem trauma evidente deve ser tratado como possível parada cardíaca mesmo que haja movimentos tipo convulsão (comum nos primeiros segundos de PCR e muitas vezes confundido com convulsão).

Quando ligar para o SAMU (192)

- Perda de consciência, convulsões, desmaio que não melhora.
- Dor no peito intensa ou prolongada.
- Falta de ar grave.
- Quedas graves/traumas (incluindo quedas de cabeça ou suspeita de lesão na coluna).
- Reação alérgica grave (anafilaxia).
- Sangramentos intensos ou fraturas expostas.

Informações que o atendente vai pedir

Tenha sempre em mente: endereço completo do dojo/local do evento com pontos de referência, telefone de contato, o que aconteceu e desde quando, número de vítimas e idade aproximada, se a vítima está consciente/respirando/sangrando. **Não desligue antes do atendente autorizar** — ele pode orientar manobras por telefone, inclusive guiar a RCP passo a passo.

2. Lesões comuns no treino e na competição

Estudos com karatecas mostram que cerca de 89% relatam ao menos uma lesão na prática, sendo mãos/dedos (15,5%) e pés/artelhos (12,8%) os locais mais frequentes. Atletas tendem a esconder lesões por medo de ser afastados — pergunte ativamente. (SciELO/RBME)

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 2 de 7

Contusões e hematomas

Fazer: parar a atividade, gelo envolto em pano por até 20 min (esperar 20 min antes de repetir, nunca gelo direto na pele), compressão leve, elevar o membro, observar evolução. **Não fazer:** calor nas primeiras 48h, massagear a área logo após o trauma. **Emergência:** hematoma muito extenso, dor desproporcional, perda de função, ou hematoma após trauma no tórax/abdômen. (Cruz Vermelha)

Entorses e luxações (tornozelo, dedos, ombro, joelho)

Trate toda lesão articular como possível fratura até prova em contrário:

1. Checar circulação/sensibilidade abaixo da lesão (cor, temperatura, formigamento).
2. Não mover, não testar a articulação.
3. Gelo por até 20 min.
4. Compressão com bandagem (deixando dedos visíveis para monitorar circulação).
5. Imobilizar com tala improvisada ou tipoia.
6. Elevar se possível.

> **Regra de ouro:** nunca tente "recolocar" uma articulação no lugar — isso é procedimento médico; feito por quem não é treinado pode lesar vasos, nervos e ligamentos. **Emergência obrigatória:** deformidade visível, pele fria/dormente/formigando abaixo da lesão, sangramento com osso exposto, mecanismo de trauma grave. Luxação sempre exige atendimento médico. (Mayo Clinic)

Fraturas (dedos, nariz, costelas, membros)

1. Mantenha a pessoa imóvel e calma.
2. Pele rompida: cubra com pano limpo, sem tocar no osso.
3. Imobilize fixando a articulação acima e abaixo da fratura, sem tentar "endireitar".
4. Gelo para dor/inchado, eleve o membro.
5. Previna choque: deite a pessoa, eleve os pés (exceto se houver suspeita de lesão na coluna/cabeça).
6. Não dê água/comida (pode precisar de cirurgia).

Fratura de costelas — sinal de alerta grave: movimento paradoxal do tórax ("tórax instável"), dificuldade respiratória, lábios arroxeados → SAMU imediato. (MSD Manuals) **Emergência:** pessoa não responde, suspeita de fratura em cabeça/pescoço/quadril, sangramento intenso, área abaixo da lesão pálida/fria/azulada, osso exposto. (MedlinePlus)

Cortes e sangramentos (nariz, lábio, supercílio)

Sangramento nasal: sente a pessoa inclinada **para a frente** (nunca para trás), pressione as narinas continuamente por 10–15 min sem soltar para checar. Emergência se não parar após 15 min ou se houver suspeita de lesão de cabeça/coluna associada. (Cruz Vermelha) **Cortes no supercílio/perto do olho:** pressione com luvas ou pano limpo, lave com água fria. Nunca pressione o globo ocular. Dor intensa, alteração de visão ou sangue dentro do olho = avaliação oftalmológica urgente. (Kaiser Permanente)

3. Lesões de cabeça e concussão

Comum após chutes/socos na cabeça ou quedas.

Sintomas relatados pelo atleta: dor de cabeça, náusea/vômito, problemas de equilíbrio/tontura, visão dupla/embaçada, sensibilidade a luz/ruído, confusão mental, dificuldade de concentração. **Sinais observados por terceiros:** aparência atordoada, confusão sobre momento/local, esquecimento de instruções, movimentos desajeitados, perda de consciência (mesmo breve), mudança de humor.

🚩 Sinais de alerta — acionar SAMU (192) imediatamente

- Dor/sensibilidade no pescoço
- Visão dupla
- Fraqueza, formigamento ou queimação em braços/pernas
- Dor de cabeça intensa ou que piora progressivamente
- Convulsões
- Nível de consciência piorando
- Vômitos repetidos
- Agitação/comportamento agressivo crescente

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 3 de 7

Conduta imediata (suspeita de concussão, sem sinais de alerta)

1. Retire o atleta imediatamente do treino/competição — **nunca permita retorno no mesmo dia**, mesmo que ele diga estar bem.
2. Não deixe a pessoa sozinha nas horas seguintes.
3. Garanta uma noite de sono completa.
4. Reduza telas e esforço mental nos dias seguintes.
5. Agende avaliação médica (neurologista/clínico) — o retorno ao tatame deve ser decidido por médico, nunca pelo instrutor.

Regra de ouro: "na dúvida, tire de jogo" (*when in doubt, sit them out*). (Fact sheet CDC HEADS UP)

4. Emergências com risco de vida

Suspeita de lesão na coluna cervical

Suspeite sempre que houver impacto em cabeça, face, pescoço ou dorso (queda de cabeça, projeção mal executada, nocaute com queda rígida).

Por que não mover: mover a vítima pode causar lesão medular permanente (paralisia) que não existia no momento do trauma.

1. **Não mova a vítima**, exceto risco imediato à vida (ex. incêndio) — nesse caso, mantenha cabeça e pescoço alinhados ao corpo.
2. Oriente a vítima a ficar imóvel, fale com calma.
3. Se precisar abrir via aérea em vítima inconsciente: use a **tração da mandíbula** (empurrar o ângulo da mandíbula para frente), nunca a inclinação da cabeça com elevação do mento.
4. Estabilize a cabeça com as mãos (uma de cada lado, sem tracionar) até o SAMU chegar.
5. Ligue para o SAMU (192) e informe "suspeita de lesão na coluna/traumatismo craniano".
6. Relate ao SAMU: perda de consciência (mesmo breve), confusão mental, vômitos repetidos, dor/formigamento que desce pelos membros, fraqueza, pupilas desiguais, sangramento/líquido claro pelo nariz ou ouvido.

Convulsões durante a atividade

Durante a crise: não contenha a pessoa, não coloque nada na boca dela (mito perigoso). Afaste objetos/pessoas, proteja a cabeça com algo macio, cronometre a duração. **Após a crise:** se inconsciente mas respirando, coloque em posição de recuperação (de lado), mantenha via aérea livre, verifique lesões, tranquilize (geralmente fica confusa). **Ligue para o SAMU se:** é a primeira convulsão da vida da pessoa, dura mais de 5 min, uma segunda crise começa logo após, há lesão, ou não recobra consciência normal.

Engasgo/obstrução de via aérea (protetor bucal quebrado, fragmento de dente)

Pessoa consciente, tossindo com força: deixe tossir, não interfira. **Não consegue tossir/falar/chorar (obstrução grave):**

1. 5 tapotagens firmes entre as escápulas, tronco inclinado para frente.
2. Se não resolver, 5 compressões abdominais (Heimlich): abrace a cintura por trás, punho um pouco acima do umbigo, pressione para dentro e para cima.
3. Alterne os dois até o objeto sair ou a pessoa ficar inconsciente.

Se ficar inconsciente: deite no chão, remova o objeto da boca só se visível (nunca "varredura às cegas"), inicie RCP.

Parada cardiorrespiratória e RCP

A morte súbita cardíaca é a principal causa médica de morte em atletas; o "*commotio cordis*" (impacto direto no tórax sobre o coração em momento vulnerável) é relevante no kumite. Colapso súbito sem trauma evidente = presuma parada cardíaca. (revisão PMC 2023)

Sobrevida por tempo de desfibrilação: choque em até 3 min = 74% de sobrevida; depois de 3 min cai para 49%. Sem RCP nem DEA, a sobrevida é de apenas 7%; com RCP isolada, 9%; com choque de DEA, 38%.

RCP passo a passo (diretrizes AHA, vigentes desde 2015/2018 e confirmadas em 2025):

1. Confirme ausência de resposta e respiração normal.
2. Posicione a vítima de barriga para cima em superfície rígida.
3. Mãos no centro do peito (metade inferior do esterno), uma sobre a outra, dedos entrelaçados.
4. Compressões a 100–120 por minuto, profundidade de 5 a 6 cm, permitindo retorno total do tórax entre compressões.

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 4 de 7

5. Ciclo 30:2 (30 compressões, 2 ventilações) para quem é treinado; para quem não sabe ventilar, **RCP só com as mãos** (compressões contínuas) é a recomendação oficial.
6. Troque de reanimador a cada 2 min se houver mais de uma pessoa.
7. Continue até a vítima reagir, o DEA orientar, ou o socorro assumir.

Uso do DEA: ligue o aparelho (ele guia por voz), posicione as pás conforme o desenho, afaste todos durante a análise/choque, retome a RCP imediatamente após. Seque o tórax se estiver com suor antes de aplicar as pás.

Divida tarefas entre 3 pessoas: (1) inicia RCP, (2) busca o DEA, (3) liga para o SAMU 192.

5. Emergências clínicas

Desmaio/síncope

Perda de consciência breve (\~1 min), pele pálida/sudorese.

1. Checar segurança, responsividade, respiração.
2. **Não responde e não respira normalmente** → inicie RCP e use DEA (suspeite de parada cardíaca).
3. Respira mas não responde → posição de recuperação, acione o SAMU.
4. Responde → monitore, evite resfriar/superaquecer, tranquilize.

Hipoglicemia

Comum após pular refeição antes do treino/competição ou esforço mais intenso que o habitual. **Sinais:** confusão, pele fria e pegajosa, batimentos rápidos, tontura/tremor, aparência de "embriaguez" (não presuma álcool), hálito adocicado.

1. **Consciente e consegue engolir:** dê \~20g de açúcar rápido (suco de laranja, balas com açúcar, gel de glicose).
2. **Inconsciente ou não consegue engolir:** não dê nada por via oral, posição de recuperação, acione o SAMU imediatamente.

Crise de asma

Sinais: chiado no peito, tosse, respiração rápida/curta, dificuldade de falar frases completas, lábios/rosto azulados (sinal grave).

1. Ajude a sentar em posição confortável, inclinada para frente.
2. Ajude com a bombinha do próprio atleta, seguindo a orientação dele.
3. Observe por 10–15 min.
4. **Ligue para o SAMU se:** lábios/rosto azulados, não consegue falar, piora rápido, sem melhora com a medicação, ou é a primeira crise sem diagnóstico conhecido.

Choque anafilático (alergias)

Sinais: calor generalizado, coceira e vermelhidão que se espalha, podendo progredir para falta de ar, inchaço de face/garganta, queda de pressão, desmaio.

1. Se o atleta **já tem** autoinjetor de epinefrina prescrito: ajude a usar imediatamente (coxa externa, mesmo através da roupa, mantendo firme por 3 segundos).
2. **Ligue para o SAMU imediatamente** — mesmo que os sintomas melhorem, pode haver uma segunda onda (reação bifásica).
3. Deite a pessoa, eleve as pernas (exceto se houver dificuldade respiratória — nesse caso, sente).

> **Importante:** o professor não pode aplicar medicação em atleta sem prescrição própria, mas **pode e deve** ajudar o atleta a usar a própria medicação de emergência já prescrita. Recomenda-se que a ficha de inscrição de cada atleta informe alergias conhecidas.

6. Cãibras e calor (campeonatos longos)

Cãibras

Ligadas à desidratação/perda de eletrólitos e fadiga neuromuscular. Pare a atividade, alongue devagar e de forma prolongada o músculo afetado, hidrate com isotônico, massageie levemente.

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 5 de 7

Exaustão pelo calor (heat exhaustion)

Sinais: pele fria e **úmida**, pálida/acinzentada, dor de cabeça, náusea, tontura, fraqueza, respiração acelerada — a pessoa responde normalmente.

1. Leve para local fresco e ventilado.
2. Afrouxe/remova roupas apertadas (atenção ao kimono).
3. Panos frios úmidos na pele.
4. Se consciente: pequenos goles de isotônico ou água de coco.
5. Só retome a atividade horas depois, com sintomas totalmente resolvidos.

Não faça: não dê comprimidos de sal (mito, piora a desidratação); não dê líquidos se a pessoa não conseguir engolir ou estiver com a consciência alterada.

Golpe de calor / insolação — emergência com risco de vida

Diferença chave: no golpe de calor a sudorese **para** (pele seca ou pouco úmida) e há alteração de consciência/confusão — sinal de piora grave.
Sinais: pele seca ou pouco úmida, respiração rápida e superficial, convulsão, inconsciência/não responde, pulso acelerado e fraco, confusão, náusea/vômito.

1. **Ligue para o SAMU (192) imediatamente.**
2. Resfrie a pessoa com compressas/bolsas de gelo, toalhas resfriantes, banho frio, água + abanar — combine métodos.
3. Mantenha o resfriamento por 20 min ou até a melhora/chegada do socorro.
4. Monitore continuamente.

Considerando que karatecas, muitas vezes crianças e adolescentes, competem em campeonatos de um dia inteiro, dê destaque à hidratação preventiva e ao reconhecimento precoce do golpe de calor — um risco frequentemente subestimado em federações esportivas brasileiras.

7. Lesões dentárias e orais

Dente arrancado (avulsão)

1. Encontre o dente e segure **apenas pela coroa** (nunca pela raiz).
2. Se possível, reimplante no alvéolo imediatamente, alinhado, e morda uma gaze para fixar.
3. Se não for possível reimplantar: guarde em **leite de vaca** ou na saliva da própria pessoa (nunca em água ou seco).
4. Compressa fria por fora da boca para dor; gaze com pressão direta para sangramento.

Não faça: não toque/raspe a raiz, não limpe com álcool/peróxido/escova, não deixe secar. **Urgência:** procure um dentista imediatamente — quanto mais rápido, maior a chance de salvar o dente. Só dentes permanentes são reimplantados.

Suspeita de fratura de mandíbula

Se os dentes superiores/inferiores não encaixam mais ao fechar a boca, suspeite de fratura de mandíbula → atendimento hospitalar/odontológico imediato.

Dente apenas lascado, sem dor, não é emergência, mas deve ser corrigido depois para evitar bordas cortantes.

8. Prevenção e estrutura

Kit de primeiros socorros do dojo/evento

Luvas descartáveis, máscara de barreira para RCP, lenços antissépticos, fita e ataduras elásticas, tipoia, curativos adesivos, gaze estéril e não aderente, soro fisiológico, antisséptico, tesoura, pinça, gelo instantâneo, colar cervical e prancha rígida (eventos maiores), e um desfibrilador (DEA) — recomendado pelo CFM como item presente na área de competição. Mantenha também o cartão de emergência médica do atleta (alergias, condições conhecidas) e telefones de contato.

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 6 de 7

Equipamentos de proteção obrigatórios no kumite (WKF/CBK)

Protetor bucal, luvas aprovadas, protetor de tronco homologado, caneleiras, protetores de pé, protetor genital masculino homologado. Menores de 14 anos: máscara facial ou capacete + protetor de peito externo. O árbitro/supervisor confere o uso antes de cada luta.

Protocolo de atleta lesionado na área de combate (referência WKF)

- O árbitro detecta a lesão, levanta a mão e chama o médico; se o atleta estiver inconsciente, só médico e árbitro permanecem na área.
- Prazo de até 3 minutos de avaliação/tratamento antes da decisão de aptidão.
- **Regra dos 10 segundos:** se o atleta cai e não se recupera totalmente em 10s, é considerado inapto e retirado de todas as lutas do evento — exame médico obrigatório antes de retomar.
- A decisão final de aptidão é sempre do árbitro, com base na opinião do médico.
- Em caso de concussão com perda de consciência: remoção de maca, nunca deixar o atleta sem acompanhamento, e retorno exige atestado de neurologista.

Boas práticas de prevenção

Árbitros tecnicamente qualificados são a principal defesa contra lesões graves. Faça exame médico pré-participação (histórico + exame clínico), nunca permita retorno precoce após sintomas de concussão, e promova treinamento periódico em RCP/DEA para professores, árbitros e atletas — inclusive como pré-requisito para graduação de faixa marrom/preta. (CFM)

Plano de Ação de Emergência (PAE) — recomendação para a FIKARJ

Tenha um plano escrito para cada local de treino/evento: hospital de referência pré-definido, localização do DEA mais próximo (acessível em até 2 min), ao menos um responsável treinado em primeiros socorros por evento, e registro formal de lesões ocorridas.

9. Resumo — o que compete e o que não compete ao professor

Compete ao professor	Não compete (e pode ser perigoso tentar)
Avaliar a cena e a vítima (segurança, responsividade, ABC)	Diagnosticar a causa exata da lesão
Ligar para o SAMU (192) e seguir a orientação telefônica	Decidir que "não é grave o suficiente" quando há qualquer sinal de alerta
Iniciar RCP e usar o DEA quando indicado	Reduzir luxações ou recolocar fraturas no lugar
Fazer manobra de desengasgamento (tapotagens/Heimlich)	Administrar medicação que não seja do próprio atleta
Controlar sangramento com pressão direta	Mover vítima com suspeita de lesão na coluna (exceto risco de vida iminente)
Imobilizar por posicionamento (tala, tipoia)	Permitir retorno ao tatame no mesmo dia após suspeita de concussão
Ajudar o atleta a usar a própria medicação de emergência já prescrita (bombinha, autoinjetor)	Minimizar sintomas ("é só uma pancada")
Manter a calma do grupo e seguir a orientação do SAMU	Deixar a pessoa ir embora/dirigir sozinha após trauma de cabeça

Regra de ouro final: na dúvida, sempre ligue para o SAMU (192) — o atendente pode orientar manobras por telefone, inclusive guiar a RCP passo a passo, enquanto a ambulância está a caminho.

Produzido por: Roosevelt Barbosa — Presidente da FIKARJ — Tel. (24) 98176-5707
Página 7 de 7